UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME FINAL DE ESTUDIANTE

DATOS INFORMATIVOS DEL ESTUDIANTE PRACTICANTE

APELLIDOS Y NOMBRES: ESTOS DATOS YA LES LLENO	
CÉDULA:	**TELÉFONO:**
PROGRAMA DE MAESTRÍA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE CENTROS HOSPITALARIOS	**MODULO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE CENTROS HOSPITALARIOS.**

DATOS DEL PROYECTO DE SERVICIOS COMUNITARIO

NOMBRE DEL PROYECTO	Promoción de la Salud Integral y Prevención Primaria en Comunidades Vulnerables: una intervención interdisciplinaria desde los programas de posgrado.		
FECHA DE INICIO DE PROYECTO	25 DE SEPTIEMBRE 2026	**FECHA FINAL DE PROYECTO**	11 DE OCTUBRE 2026
DIRECTOR DEL PROYECTO			

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO : ESTOS DATOS YA LES LLENO			
CIUDAD: ESTOS DATOS YA LES LLENO **DIRECCIÓN:**			
TIPO DE BENEFICIARIO: INSTITUCIÓN/COMUNIDAD	**PÚBLICA ☐**	**PRIVADA ☐**	**OTRA: ☐**
TELÉFONO:		**CORREO:**	

DATOS DE LA PRÁCTICA DE SERVICIO COMUNITARIO CON EL BENEFICIARIO

FECHA DE INICIO DE LA PRÁCTICA	25 DE SEPTIEMBRE 2026	**FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA**	**11 DE OCTUBRE 2026**
TUTOR ACADÉMICO			
NÚMERO HORAS REALIZADAS	**10 HORAS**		

1.- Descripción detallada de las tareas realizadas durante la práctica de servicio comunitario.

En el marco del proyecto de servicio comunitario “Promoción de la Salud Integral y Prevención Primaria en Comunidades Vulnerables: una intervención interdisciplinaria desde los programas de posgrado”, durante el periodo comprendido entre el 25 de septiembre y el 11 de octubre de 2026 se ejecutó una intervención educativa sobre la prevención del consumo de tabaco, con un total de 10 horas de práctica. Los objetivos fueron informar a la población sobre los riesgos asociados al tabaquismo y promover medidas orientadas a prevenir su consumo.

La intervención se orientó desde el enfoque de la prevención primaria y la promoción de la salud, que busca actuar sobre los factores de riesgo antes de que aparezca la enfermedad. El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo evitables para las enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas y oncológicas. Además, la exposición al humo de tabaco ajeno afecta de manera particular a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Las actividades realizadas fueron las siguientes:

a) Planificación y revisión de fuentes. Se revisó información de fuentes oficiales y científicas sobre las consecuencias del consumo de tabaco, sobre el humo de segunda mano y sobre las estrategias de prevención recomendadas por organismos de salud pública. Con base en esta revisión se definieron la población objetivo, los mensajes clave y la metodología de abordaje en cada domicilio.

b) Diseño del material educativo. Se elaboró un tríptico informativo con lenguaje claro, accesible y apoyo gráfico, estructurado en tres ejes: los daños del tabaco a la salud, las medidas para proteger a la familia y los beneficios de no consumir o de abandonar el consumo. El material se diseñó para que las personas pudieran conservarlo, consultarlo y compartirlo con otros miembros del hogar.
c) Visitas domiciliarias de educación en salud. Se visitó a familias de la comunidad beneficiaria. En cada visita se presentó el propósito de la intervención, se indagó de manera respetuosa sobre la percepción de las personas acerca del consumo de tabaco y se explicaron sus riesgos para la salud individual y familiar. Se entregó el tríptico y se aclararon las dudas planteadas, con un enfoque de diálogo y sin juzgar a las personas.
d) Promoción de medidas preventivas. Se promovieron prácticas concretas: mantener los hogares y espacios compartidos libres de humo, proteger a niños y adultos mayores de la exposición, retrasar o evitar el inicio del consumo en adolescentes y jóvenes, adoptar estilos de vida saludables y acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir orientación y apoyo en caso de querer dejar de fumar.
e) Registro, sistematización y cierre. Se llevó un registro fotográfico de las actividades como evidencia, se organizó la información de las visitas y se elaboró el presente informe, con la valoración de resultados, las lecciones aprendidas y las recomendaciones para dar continuidad a la intervención.

2.- Recursos utilizados.
Para el desarrollo de la práctica se emplearon los siguientes recursos:
Recursos humanos: el estudiante practicante, el tutor académico, el equipo de asociados del proyecto y las familias de la comunidad beneficiaria, cuya participación y apertura fueron esenciales para la ejecución.
Recursos materiales: trípticos informativos impresos, útiles de oficina y material de apoyo para la entrega de información en los domicilios.
Recursos tecnológicos: computador, teléfono móvil para el registro fotográfico, acceso a internet, herramientas ofimáticas y de diseño para elaborar el material educativo, y la plataforma GitHub para almacenar y compartir las evidencias.
Recursos documentales: guías, normativa y publicaciones oficiales sobre prevención y control del tabaquismo, así como los contenidos académicos del programa de maestría.
Recursos logísticos: movilización a los domicilios visitados y organización del tiempo disponible para cumplir las horas de práctica.

3.- Describa los problemas presentados en la práctica de servicio comunitario y el procedimiento seguido para su resolución.
Durante la ejecución de la práctica se presentaron algunas dificultades, que se abordaron mediante los siguientes procedimientos:
1) Ausencia de moradores en algunos domicilios. Ante la imposibilidad de realizar la visita en el momento previsto, se reprogramó en otros días y horarios, dentro del periodo del proyecto, y se priorizó el contacto con los miembros del hogar disponibles.
2) Poca receptividad o minimización del riesgo. Algunas personas mostraron escepticismo o consideraron que el consumo de tabaco no representaba un problema relevante. Se respondió con un trato respetuoso, sin juzgar, con ejemplos cotidianos cercanos a su realidad y con mensajes breves y positivos, centrados en el cuidado de la familia y en los beneficios de la prevención.
3) Dificultad para comprender la terminología técnica. Se adaptó el lenguaje, evitando tecnicismos innecesarios, y se apoyó la explicación en el tríptico ilustrado, que facilitó la comprensión de los mensajes.
4) Tiempo limitado de la práctica. Dado que la práctica comprendió 10 horas, se priorizaron los mensajes esenciales y se organizaron las visitas para aprovechar mejor el tiempo y alcanzar a un mayor número de familias.
Estas situaciones permitieron desarrollar capacidades de adaptación, comunicación efectiva y planificación, propias de la gestión de intervenciones en salud en contextos comunitarios.

4. Identifique las asignaturas que han aportado en sus prácticas y relacione con las actividades realizadas.
Los conocimientos adquiridos durante la maestría se aplicaron en la práctica de la siguiente manera:
Sistemas de Información para la Gestión de Centros Hospitalarios: este módulo aportó la comprensión del valor de la información en salud para la toma de decisiones. Se aplicó en el registro ordenado de las

visitas y de las evidencias, en la sistematización de la experiencia y en el diseño de material informativo claro, confiable y comprensible para la población, así como en el uso de herramientas digitales para almacenar y compartir la documentación.

Asignaturas del área de gestión en salud y salud pública: proporcionaron las bases conceptuales para planificar y ejecutar una intervención de promoción de la salud y prevención primaria: identificación de riesgos, definición de objetivos, selección de la población objetivo y comunicación de mensajes preventivos adaptados al contexto comunitario.

Asignaturas de calidad y atención centrada en el usuario: orientaron el trato respetuoso, la comunicación empática y la búsqueda de que las familias comprendieran la información y pudieran aplicarla en su vida cotidiana.

Asignaturas de planificación y liderazgo: fortalecieron la organización del tiempo, la coordinación con el tutor y el equipo del proyecto, y la capacidad de resolver problemas durante la ejecución.

5. Contribución del proyecto al perfil del estudiante (AUTO CALIFICA EL ESTUDIANTE)

Calificar cualitativamente el nivel de satisfacción considerando la contribución de las actividades desarrolladas con el perfil del programa de la maestría:

ÍTEMS		Nivel de Satisfacción		
		Alto	Medio	Bajo
1.	Cumplir con el perfil de egreso	☒	☐	☐
2.	Lograr los resultados de aprendizaje	☒	☐	☐
3.	Fortalecer las competencias profesionales	☒	☐	☐
4.	Fortalecer su parte solidaria y humanista	☒	☐	☐
5.	Contribuir al desarrollo local	☒	☐	☐

6. Conclusiones:

La práctica de servicio comunitario permitió cumplir los objetivos propuestos. Se informó a las familias visitadas sobre los riesgos asociados al tabaquismo, en particular su relación con las enfermedades respiratorias, cardiovasculares y oncológicas, y sobre el daño que produce la exposición al humo de segunda mano, especialmente en niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. De este modo se contribuyó a que las personas reconozcan el tabaco como un riesgo prevenible para la salud.

Asimismo, se promovieron medidas orientadas a prevenir el consumo: mantener entornos libres de humo, proteger a la población más vulnerable, evitar el inicio del consumo en adolescentes y jóvenes, adoptar estilos de vida saludables y buscar apoyo en los servicios de salud. La entrega de un tríptico educativo reforzó los mensajes y dejó en cada hogar información útil para consultar y compartir.

Las visitas domiciliarias resultaron una estrategia cercana y eficaz de educación en salud en comunidades vulnerables, porque permiten un diálogo directo, adaptado a la realidad de cada familia y basado en la confianza. Se comprobó que el trato respetuoso, el lenguaje sencillo y los mensajes positivos favorecen la receptividad frente a un tema que suele generar resistencia.

En el ámbito formativo, la experiencia permitió integrar conocimientos de la maestría con la práctica real, fortaleció las competencias profesionales en planificación, comunicación, gestión de la información y trabajo en equipo, y reforzó el compromiso solidario y humanista del estudiante. En síntesis, la práctica aportó al desarrollo local y confirmó que la prevención y la promoción de la salud son un eje central de la gestión de los servicios de salud.

7. Recomendaciones:

Con base en la experiencia desarrollada y en las conclusiones expuestas, se formulan las siguientes

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME FINAL DE ESTUDIANTE

recomendaciones:
1. Dar continuidad a las acciones de educación y prevención del consumo de tabaco en la comunidad, mediante nuevas visitas, charlas y material informativo, para consolidar los resultados alcanzados y evitar que la intervención quede como una acción aislada.
2. Fortalecer la articulación con los establecimientos de salud locales y con los líderes comunitarios, de modo que las personas que deseen dejar de fumar reciban orientación, seguimiento y acceso oportuno a los servicios de apoyo.
3. Priorizar a niños, adolescentes y jóvenes en las próximas intervenciones, en coordinación con instituciones educativas, por ser el grupo en el que resulta más efectivo evitar el inicio del consumo.
4. Establecer un registro sistemático de las visitas y de las personas alcanzadas, con indicadores sencillos, que permita evaluar el efecto de la intervención y mejorar las próximas prácticas con base en evidencia.
5. Programar un mayor número de horas y horarios flexibles de visita, incluso fuera de la jornada laboral habitual, para llegar a más familias y reducir las ausencias en los domicilios.
6. Mantener el diseño de material educativo con lenguaje claro y apoyo gráfico, y evaluar periódicamente su comprensión por parte de la comunidad para actualizarlo cuando sea necesario.

8. Evidencias (Enlace carpeta) EN FOTO Y ENLACE
Enlace a la carpeta de evidencias (GitHub): [PEGAR AQUÍ EL ENLACE]
Anexos: fotografías de las visitas domiciliarias y tríptico informativo sobre la prevención del consumo de tabaco.
Se deberá anexar las evidencias más relevantes de la ejecución tales como:

_____ **Firma estudiante** **Nombre Estudiante**	_____ **Asociados del Proyecto**

LOS ANEXOS TENGO FOTOS DE VISITAS DOMICILIARIAS Y TRIPTICOS COMO ESTE

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME FINAL DE ESTUDIANTE



Figura 1 Tríptico informativo "Prevención del tabaco en Ecuador", entregado a las familias visitadas.



Figura 2 Tríptico informativo ¨Prevención del tabaco ¨





Figura 3 Visita domiciliaria, de octubre de 2026: explicación de los riesgos del tabaquismo a una familia de la comunidad.





Figura 4 Visita domiciliaria, de octubre de 2026: entrega del tríptico sobre prevención del consumo de tabaco.

UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME FINAL DE ESTUDIANTE

